智力障碍儿童性教育研究的系统综述*

张 杨** 陈 诺 盛菲菲 王振洲*** 梁 剑
(乐山师范学院特殊教育学院,乐山,614000)

摘要 为探索智力障碍儿童性教育面临的挑战及发展路径,文章采用系统综述法,发现智力障碍儿童性教育内涵强调性健康与关系建立,性教育理论与实践关注适合的性教育,但智力障碍儿童性教育有效性与规律揭示仍不充分;智力障碍儿童性教育主体较为多元,其专业能力受到关注,但由于相关政策规定较为模糊,教育主体难以履行权责;课程体系聚焦智力障碍儿童的性教育需求;由于评估不足,性教育课程难以满足智力障碍儿童个性化发展需要。未来智力障碍儿童性教育发展需通过完善顶层设计明确性教育主体权责,借助数智技术创新智力障碍儿童性教育服务,依托跨学科合作构建多元主体合作支持网络,还应基于科学评估持续优化性教育实践。

关键词 智力障碍儿童 性教育 性健康
分类号 G764

1 引言

智力障碍儿童具有性与关系发展的需要,应平等获得与其年龄、发展水平相适应的健康教育、保护和支持。联合国教科文组织指出高质量的性教育可以帮助学习者掌握必备的知识和技能,从而保持身心健康、实现自我赋权,并建立积极、性别平等的人际关系[1]。《中华人民共和国未成年人保护法》第四十条规定学校应对未成年人开展适合其年龄的性教育,提高未成年人防范性侵害、性骚扰的自我保护意识和能力[2],《教育部关于全面推进健康学校建设的指导意见》中要求学校开展防欺凌、防艾等安全教育,提高未成年人防范性侵害、性骚扰的自我保护意识和能力[3]。《中华人民共和国家庭教育促进法》第十六条强调家庭教育要对未成年人开展防性侵方面的安全教育,明确了学校和家庭的主体责任与义务[4]。

尽管智力障碍儿童的性兴趣、性活动与非残疾学生相似,但是其理解能力和心理能力低[5],加之伴随的沟通障碍,使其欠缺建立关系、获取必要的社交网络和性教育支持的能力[6],容易表现出不当的性行为,增加教育者的照料负担[7]。研究表明忽视、限制或禁止智力障碍儿童掌握适当性行为所必需的信息和技能,将使其比非残疾同龄人经历更高的性胁迫、性虐待、性侵犯及感染性传播疾病的风险[8]。有数据显示,智力障碍人士意外怀孕和感染性传播疾病的风险是普通人群的两倍[9],性虐待的发生率是普通人群的2至8倍[10]。因此,为智力障碍儿童提供适合的性教育有助于其增长性知识[11]、形成积极的行为模式和价值判断[12]、区分适当和不当的性行为,保障其性健康自决权(sexual health self-determination),避免性虐待发生[13],消除残疾和性行为相关的污名和误解[14]。

2 研究方法

2.1 文献检索

为尽可能确保文献样本准确可靠,研究选取国际权威数据库 Web of Science 和北大核心、CSSCI、CSCD 数据库,拟定以下两类检索词:(1)性教育(sexuality、sex education、sexuality education);(2)智力障碍/智力残疾/智力落后(intellectual developmental disorders、intellectual disabilities、intellectual disability、mental retardation)。通过关键词、符号组合及布尔运算,调整数据库的检索参数。检索不限时间范围,检索日期为2026年6月30日,语言限定为英文和中文,初步获得1066篇文献。对研究主题相关的综述类文献进行回

* 本研究是2023年四川省哲学社会科学重点研究基地:四川性社会学与性教育研究中心课题"智力障碍儿童学校性教育困境及对策研究"(课题编号:SXJYB2312)的阶段性成果之一。
** 张杨,博士,副教授,研究方向:特殊教育管理、融合教育。E-mail:zhangziyang66@163.com。
*** 通讯作者:王振洲,博士,副教授,研究方向:融合教育。E-mail:2019101160002@whu.edu.cn。

中国知网 https://www.cnki.net

溯,补充文献16篇,共获得1082篇文献。

2.2　文献纳入与排除

本研究采用系统综述法,并依据系统综述与元分析优先报告条目(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses,PRISMA 2020),对文献进行了筛选(见图1)。数据纳入与排除标准:研究主题为0~18岁智力障碍儿童性教育内容、课程等理论与实践;排除医疗、护理等非教育类文献;排除重复发表、同一研究多源发表的文献。文献筛选首先剔除重复文献9篇;其次,阅读题目与摘要后排除与主题不相关文献932篇,得到141篇文献;最后,通过阅读全文筛选文献,确定纳入系统分析文献67篇,其中英文文献61篇、中文文献6篇。两名研究人员评分者间一致性为89%。

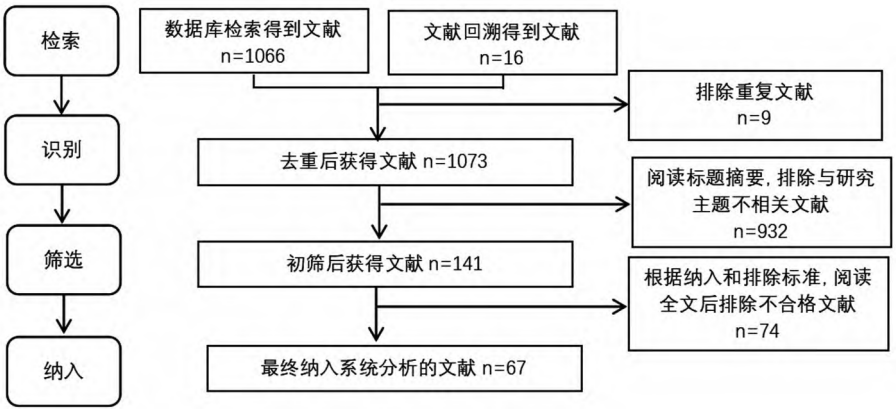


图1　文献筛选流程

2.3　文献编码与系统综述框架

将上述文献导入质性分析软件(Nvivo 12),对其进行三级编码(见表1),提取智力障碍儿童性教育研究中具有代表性的概念为子节点(child nodes),并将其纳入相应的节点(nodes)。在对文献原始语句概念化和抽象化之后,最终形成四个核心主题分析框架:智力障碍儿童性教育内涵、智力障碍儿童性教育理论与实践、智力障碍儿童性教育主体、智力障碍儿童性教育课程体系。

3　智力障碍儿童性教育研究的主要内容

3.1　性教育内涵侧重于性健康与关系建立

科学地界定性教育是开展适合性教育的前提。从内容上看,性教育是一个多维活动。有学者认为性教育不仅要传播性生理知识,还要灌输适应当前社会的性道德意识、法律规范等,培养一个人对两性关系、友谊、爱情、两性道德、社会道德与心理观点的正确理解,促进其生存和健康发展[15]。有学者采用2018年联合国教科文组织提出的综合性教育概念,认为性教育是促进与个体性行为有关的认知、情感、身体和社会方面的教学活动[16];有学者强调性教育是个体学习身体和身体形象、情感和触觉、信仰和价值观,也是形成性别认同和性别角色的过程[17]。英国教育部推行的"关系和性教育"(Relationships and Sex Education)课程被视为贯穿个体一生的学习*,涵盖信息获取、树立对自我与他人的尊重,并对身份认同、人际交往、生育、性健康和亲密关系等形成自身态度和价值理念[18]。综上可知,在智力障碍儿童性教育研究中,性教育的内涵早已突破了生殖行为的医学范畴,更强调智力障碍儿童对其身体、情感等有关性发展的理解。

3.2　性教育理论与实践重视提供适合的性教育

有学者运用社会认知理论[19]、健康信念模型和复发预防理论[20]、生态系统理论[21]、社会学习理论[22]、人际圈理论[23]等揭示智力障碍儿童性教育规律与有效教育实践。N. N. 卡迈鲁丁(N. N. Kamaludin)等人运用社会认知理论提出了个人、环境和行为相互作用的"互惠三元互动模型",强调应从身体认知、卫生保健和自我照料、社交技能、隐私保护、安全应对和情绪处理五个方面开展性教育[24]。在实践研究层面,适合的性教育可增强智力障碍儿童韧性,指导其何时、如何寻求帮助,并使其清楚可以获得哪些支持。最常见的性教育主题是安全性行为的重要性(如使用避孕套)、不安全性行为(如性传播感染)的后果、公共和私人行为之间的差异及性虐待预防。对于智力障碍女童来说,经期卫生、避孕、怀孕也是常见的教育主题[25]。有研究强调适合的性教育包含了解性别差异、身体知识、性满

*　注:2017年英国《儿童和社会工作法》(Children and Social Work Act)规定,自2020学年起,"关系和性教育"课程将成为英国义务教育阶段学校必修课,学校必须为所有学生(包括特殊教育需要学生)提供无障碍和包容性的关系与性教育课程,学校教育者须根据学生年龄和宗教背景,确定所提供的教育是合适的。

中国知网　https://www.cnki.net

表1　智力障碍儿童性教育研究文献编码示例

节点	子节点	案例数(N = 73)	参考点数量	编码示例
性教育内涵	性健康	65	72	The World Health Organization (WHO) defines sexual health as, a state of physical, emotional, mental and social well being in relation to sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity.
	关系教育	30	63	UNESCO defines Comprehensive sex education (CSE) as "an age-appropriate, culturally relevant approach to teaching about sexuality and relationships by providing scientifically accurate, realistic, non-judgmental information".
性教育理论与实践	理论	9	21	McLeroy, Bibeau, Steckler, and Glanz (1988) developed a multilevel framework (SEM) based on the work of Urie Bronfenbrenner (1977) to articulate level-specific effects on health behavior and outlined potential intervention approaches at every level of influence.
	具体实践	67	177	当然在采用上述各种方法时,教师还会采用各种视觉、听觉教学辅助手段,同时还应用实物充实和完善教学活动,以此完成教学任务,实现教学目标。
性教育主体	家庭	52	91	For parents, being models for their children in the field of sexuality and to offer suitable educational experiences for their needs is important.
	学校	45	88	Caregivers describe schools as an important resource for sexuality education and desire more support from educators when addressing content related to sexual development.
	社会	21	52	The role of health care providers includes prompting families and caregivers to provide basic education about sexuality.
性教育课程体系	正式课程	23	38	In 2020, relationships and sex education (RSE) became compulsory in English schools for all students including those with intellectual disability.
	非正式课程	31	41	In Malaysia, SE is informally taught to Malay children in terms of appropriate personality traits and desirable behavior—to behave in "feminine" ways for girls and "masculine" ways for boys around four years of age.
	通用课程	5	17	HIPTeens was identified as the evidence-based intervention for UDL integration because it is brief, has different activities that could be modified for different learning styles, and each session focuses on skill-building, role playing, and risk assessment which can be applicable to the ID adolescent population.
	个性化课程	39	59	The examination of systematic reviews and the primary studies covered within each of them revealed a wide array of 50 RSE programmes specifically designed for individuals with intellectual disabilities.

足能力、青春期生理变化,以及掌握获取性信息的方法等内容[26]。总体来看,性教育研究更重视性角色、社交规则等教育理论和实践。

3.3　性教育主体呈多元化且其专业能力受到关注

智力障碍儿童性教育主体除教师和家长外,还包括上门服务的教育工作者、临时教育工作者、健康教育专业人员、卫生保健人员、遗传咨询师、支持专业人员、同伴等利益相关者[27]。U. T. 法迪姆(U. T.Fadime)认为作为向智力障碍儿童提供初级保健服务的父母,特别是智力障碍儿童的母亲在性教育方面发挥着重要作用[28]。学校在提供系统性、专业性的性教育服务方面优势明显。为了提高教师的专业化水平和性教育质量,美国"性教育的未来"组织发布了《国家性教育师资培养标准》(the National Teacher Preparation Standards for Sexuality Education)和《国家性教育标准》(National Sex Education Standards)[29];世界卫生组织欧洲区域办事处发起,并由德国联邦健康教育中心制定了《欧洲性教育标准》(Standards for Sexuality Education in Europe)[30]。智力障碍儿童性教育主体愈发多元,相关标准的制定旨在明确学生性教育发展所需的知识与技能,以及性教育工作者的专业职责与应具备的能力。

3.4　课程体系强调提供完整的性教育

智力障碍儿童性教育课程包括正式与非正式课程、通用与个性化课程。我国教育部发布的《培智学校义务教育课程标准》明确智力障碍儿童青春期身体发育和变化,以及促进其身心健康的方法[31]。自2020年

中国知网　https://www.cnki.net

9月起,英国义务教育课程体系纳入了关系和性教育课程,该课程在小学阶段侧重于关系教育,中学阶段则向学生提供完整的关系和性教育课程[32]。澳大利亚昆士兰州推行了“每个人都需要了解”计划(Every Body Needs To Know)*。该计划以国家课程为依托,为5~17岁四个发展阶段的残疾儿童提供性教育课程,小学低年级(5~8岁)涉及个人安全、公共和私人、学习情感;小学高年级(9~11岁)关注个人安全、公共和私人、青春期和身体变化、健康关系;初中阶段(12~14岁)强调个人安全、公共和私人、青春期、保持性健康、健康关系;高中阶段(15~18岁)以个人安全、公共和私人、保持性健康和健康关系内容为主[33]。智力障碍儿童正式的性教育课程通常由学校提供,课外与性别特质相符的行为方式、社交技能指导等非正式课程则多由学校、家庭和社会中的性教育主体共同提供。青少年健康赋能项目(HIPTeens)是一项融入通用设计的循证干预方案,其中包含4节90分钟的常规课和2节120分钟的强化课程,内容涉及性健康知识、沟通与降低风险行为的视觉演示、沟通和伴侣协商的角色扮演,以及自定义的书面活动等[34]。个性化课程则是摒弃覆盖所有学生群体的通用课程设计思路,强调精准聚焦某一类群体的特殊需要,以提升课程内容的针对性与适配度[35]。由于为普通学生提供的性教育课程不适合智力障碍儿童,在教育实践中针对智力障碍儿童特殊需要开发的性教育课程体系,已成为影响其性教育质量的关键。

4　智力障碍儿童性教育发展面临的挑战

4.1　智力障碍儿童性教育受宏观环境影响

智力障碍儿童性教育发展受政治、文化、宗教等因素制约。许多国家的性教育相关政策以社会公平、平等参与为法律框架,保障智力障碍儿童享有性教育合法权益。如,2017年英国颁布的《儿童和社会工作法》(Children and Social Work Act)规定,自2020学年起将关系和性教育课程纳入中小学教育阶段学校教育的必修课[36]。政策支持与现实执行可能存在偏离。2021年《全球综合性教育状况报告》(the Global Status Report on CSE)显示,在接受调查的155个国家中,85%的国家出台了支持性的性教育政策,但政策实施与实际课程之间存在显著差距[37]。受文化与宗教的制约,在沙特阿拉伯、印度等国家,性教育属于禁忌话题[38]。荷兰的个别化支持计划很少提及性教育[39]。受“残障”与“性”的双重污名,以及宗教禁忌对性有关话题的影响,在很多国家公开讨论性教育常被视为诱发文化与社会冲突的潜在风险[40],这也是部分国家和地区的性教育活动被过度简化、回避或抵制的原因。受宏观环境的限制,许多国家性教育受到严密的监督[41],建立和维持关系方面的性教育常被推迟于初中及以后阶段实施[42]。此外,性教育多被视为道德自觉而非应尽职责,许多教育者需要自行决定性教育活动的开展。学习者可能错过系统的教育,导致他们在识别、规避性风险,以及关系建立时缺少必要知识和技能[43]。

4.2　适合的性教育理论依据与循证实践不足

智力障碍儿童性教育具有高度的复杂性与特殊性,其有效实施亟须坚实的理论支撑与充分的循证依据。相关研究需要借鉴生态学的观点,分析多层级系统共同作用下智力障碍儿童性教育的有效性和适切性,揭示其身心发展和教育规律,才能提供满足其发展需要的教育资源。现有研究大多采取定性研究方法,主要描述家庭或学校中智力障碍儿童及其教育者的态度、观念、行为、需要与问题,对于生态系统中各场域不同要素对育人成效的影响、不同场域性教育主体协同育人的定量研究、混合研究与系统理论阐释仍显不足。此外,在数字化时代,技术的变革为智力障碍儿童性教育发展提供了机遇,有利于研发内容适切、方法适配、场景创新的无障碍性教育资源。然而,当前对于数智赋能智力障碍儿童性教育的循证实践研究明显滞后,仅有少量研究介绍了性教育在线课程[44]、网络资源建设[45]、智力障碍儿童在互联网和社交媒体获取性教育信息时面临的风险[46]。智力障碍儿童性教育理论与实践研究重在探寻如何提供适合的性教育,但当前的理论与实践研究还较为薄弱。

4.3　多元性教育主体难以履行自身权责

许多国家出台的性教育相关政策对于性教育主体权责规定还较为模糊,未能明确合作支持机制,导致智力障碍儿童性教育出现了主体缺位的现象。尽管学校性教育优势明显,但是学校性教育由谁提供的相关规定并不明确,多元性教育主体难以形成教育合力。学校需要开展许多性教育主题教学活动,特殊教育工作者常被视为负责智力障碍儿童性教育的专业人员[47],其他专业人员则认为性教育不属于其专业责任、自身不具备性教育资格,因而无法开展性教育,也很难与特殊教育教师合作提供性教育支持。特殊教育教师表示由于缺乏培训与组织支持,他们开展性教育的信心严

---

*　注:“每个人都需要了解”计划为专业人士开发了全面的教学资源(包含课程计划、活动表等),以确保专业人员能够满足他们所服务的儿童及成年人的教育需求;同时,为每个阶段学生提供4节时长为1小时的课程,为全学段特殊教育需要学生提供了学习包(包含8章课程计划、相应的活动表等),学生可与成人一起使用,也可单独学习。该计划旨在支持残疾儿童和成年人学习人际关系和性教育的核心概念。

中国知网　https://www.cnki.net

重不足[48]。

家庭是智力障碍儿童性教育的重要场域，性教育政策中家庭具体权责还不清晰。有些家长的性教育观念较为滞后，他们认为智力障碍儿童是无性的[49]或性不成熟，开展性教育将加剧其性欲，从而产生不当性行为[50]。因此，家庭性教育主体常常忽视[51]、限制为智力障碍儿童提供性教育[52]，未能履行家庭教育主体责任。尽管部分家庭为智力障碍儿童提供了性教育，但是他们表示很难获得与其子女认知能力相匹配的性教育资源，需要专业人员提供更多的支持[53]。

有些国家通过政策引导社会主体广泛参与，依托标准制定、项目支撑等方式明确性教育主体权责与能力要求，使得智力障碍儿童性教育主体呈多元化。然而，家庭、学校、社会性教育主体的观点很难达成一致，不利于实施连续性的性教育[54]。智力障碍儿童性教育需求的识别、适合的性教育活动的开展，仅靠单一主体很难实现。家校社性教育主体权责需进一步明确，多元性教育主体合作支持机制还未建立。

4.4　性教育课程难以满足智力障碍儿童的性教育需求

智力障碍儿童只有获得能够满足其性需求的性教育课程，才能享有适合的性教育。当前，许多国家没有开发适合智力障碍儿童性教育的国家课程[55]。从安置形式来看，大多数轻度、中度智力障碍儿童在普通学校接受融合教育，普通学校的性教育课程对于智力障碍儿童而言有难度。特殊教育学校提供的性教育课程，也需根据智力障碍儿童需要和发展特点做出调整。由于缺少评估智力障碍儿童性教育需求的有效工具，当前的性教育课程难以满足智力障碍儿童的性教育需求。此外，无论是普通学校还是特殊教育学校提供的课程，在信息呈现方式上多使用长句和抽象概念，不利于智力障碍儿童理解与记忆。

5　智力障碍儿童性教育研究启示与建议

5.1　完善顶层设计，保障智力障碍儿童性教育权益

智力障碍儿童性教育呈现出赋权增能的发展趋势，性教育主体愈发多元。我国政府通过出台性教育相关政策保障智力障碍儿童性教育权益，明确了家庭、学校性教育主体权责和性教育内容。然而，现有政策缺少促进社会性教育主体参与的有关规定，学校、家庭性教育主体权责也不清晰，不同阶段智力障碍儿童性教育内容未能体现出差异性与针对性。我国政府应不断完善性教育相关政策，进一步明确学校、家庭性教育主体权责，制定鼓励性政策引导社会主体广泛参与，丰富性教育的内涵与外延。此外，我国性教育相关政策多通过鼓励性政策推动智力障碍儿童性教育主体履行自身权责，对于权责履行情况、政策执行效果缺乏考核与监督。我国政府应完善顶层设计，通过约束性政策明确禁止发生的行为，形成较为完善的奖惩机制。我国政府可通过研究制定国家层面的指导标准，完善教师岗位能力标准，明确不同阶段智力障碍儿童性教育发展必备的知识与技能，为性教育政策执行与实施提供可行路径，确保智力障碍儿童享有适合的性教育，以维护智力障碍儿童性教育权益。

5.2　加强数智赋能，创新智力障碍儿童性教育服务

随着数字时代的到来，数智技术变革了传统的性教育模式，为多元主体共同参与性教育提供了新的发展机遇。智力障碍是一种终身的神经发育障碍，其特征是认知和适应能力存在局限。性教育主体采用智力障碍儿童能够接受的方式开展性教育，对于提高教育质量至关重要。性教育主体必须借助各种媒介多样化呈现性教育内容、提供额外的时间和资源支持，才能使智力障碍儿童获取适合的性教育。我国政府应鼓励和推动数智化性教育服务平台建设。一方面利用技术赋能变革传统的性教育内容呈现方式，使用VR技术、视觉提示、建模、智能问答等技术打破时空限制，以更加符合智力障碍儿童身心发展特点与认知偏好的方式，服务智力障碍儿童个性化、差异化的性教育需求。另一方面数智化性教育服务平台建设为多元性教育主体广泛参与提供了可能，智能问答与数智社区随时、随地为多元性教育主体与智力障碍儿童之间建立情感联结，可以有效避免性教育主体缺位、推迟性教育等效率低下的情况发生。此外，数智化性教育服务平台可借助算力、算法与大数据规避潜在的危害与风险，确保性教育内容的合法性与无障碍程度。

5.3　开展跨学科合作，构建多元主体合作支持网络

多元性教育主体表现出了不同的优势。学校性教育的系统性与专业性，家庭性教育的启蒙性与嵌入性，社会性教育资源与服务的丰富性与多样性，在智力障碍儿童性教育活动中发挥着各自的作用。性教育与残疾的交叉整合服务很复杂，内容涵盖教育学、心理学、社会学、性学、医学、法学、伦理学等多维学科，单一的性教育主体在面对智力障碍儿童性教育时常常感到知识与能力有限，只有加强多元性教育主体广泛参与、创新开发性教育活动所需的知识资源、实现知识资源的优化整合，才能形成多元主体合作支持网络。智力障碍儿童性教育主体跨学科合作支持网络的建立，可从以下两个方面着手：一是我国政府可依法通过购买服务、项目资助、公益合作等方式支持具备资质的社会组织参与，引导医疗、保健、社区人员参与智力障碍儿童性教育实践。依托项目式服务构建多元性教育主体合作支持网络，可发挥不同主体学科优势。二是教育行政部门可发挥国家、省、市、县、校五级特殊教育资源中

中国知网　https://www.cnki.net

心的作用,整合优质性教育资源,组建跨学科、跨机构合作支持的专业团队,在智力障碍儿童性教育评估与性教育活动中实现资源整合。

5.4 依据科学评估,优化智力障碍儿童性教育实践

适合的性教育需要精准聚焦智力障碍儿童的特殊需求。科学评估是了解智力障碍儿童性需求、选择性教育资源、判定性教育有效性的前提。智力障碍儿童的群体间、个体间差异较大,多元性教育主体需要根据评估结果确定性教育目标、课程、手段、方法等,以提高性教育活动的科学性和适用性。因此,我国性教育工作者应研发科学评估工具,并将评估集中于两个阶段。一是在开展正式或非正式教育前,性教育主体需要对智力障碍儿童真实的性教育需求进行评估,制定"一人一案"的干预计划,选择适合的教育资源。二是在性教育活动开展之后,科学评估多用于追踪长期的教育影响,性教育主体可依据评估工具判定智力障碍儿童在知识增长、自我效能感等(表明意愿、明确界限)方面的整体发展水平,确定有效策略与方法,明确未来可持续改进的方向。多元性教育主体应将科学评估融入性教育的全过程,评估既要关注教育质量,也须服务于教育判断。科学评估能够为不同学科背景性教育主体的介入、优化合作支持网络提供依据,有助于形成基于循证实践的实用策略和适合的性教育模式。

人类的性行为包含许多不同的表达形式,对智力障碍儿童性行为及表达多样性的认识是识别其性教育活动中可获得、可接受、可持续、可实施的有效资源和发展路径的重要前提,有助于提升智力障碍儿童及其家庭的整体幸福感和健康感。智力障碍儿童性教育理论与实践旨在通过多元性教育主体制定以循证为基础和以人为本的适合的性教育方案,向智力障碍儿童赋权增能,保护智力障碍儿童免受性虐待,形成识别和抵御风险的能力,明确两性界限和性表达的适切性,提高其身心健康水平和生活质量,确保他们在社会生活中得到应有的尊重。

参考文献

1 UNESCO. Comprehensive sexuality education: For healthy, informed and empowered learners. https://www.unesco.org/en/health-education/cse,2026-04-21

2 民政部.中华人民共和国未成年人保护法.https://www.mca.gov.cn/n2445/n2575/n2576/c1662004999980004490/content.html,2026-04-21

3 教育部.教育部关于全面推进健康学校建设的指导意见.http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/moe_946/202602/t20260227_1429365.html,2026-04-21

4 妇女儿童工作委员会.中华人民共和国家庭教育促进法.https://www.nwccw.gov.cn/2021/10/26/99335108.html,2026-04-21

5 刘中一.国外智力残疾者性相关议题的研究进展.社会工作,2015,(4):116-122,128

6 McCann E, Marsh L, Brown M. People with intellectual disabilities, relationship and sex education programmes: A systematic review. Health Education Journal, 2019, 78(8):885-900

7 关晓阳.智力落后学生性健康教育初探.中国健康教育,2002,(7):27-29

8 McCabe M P, Cummins R A, Reid S B. An empirical study of the sexual abuse of people with intellectual disability. Sexuality and Disability, 1994, 12(4): 297-306

9 32 Paulauskaite L, Totsika V, Rivas C. Relationships and sex education outcomes for students with intellectual disability: Protocol for the development of a core outcome set. Jmir Research Protocols, 2022, 11(11):1-12

10 Jojo N, Nattala P, Seshadri S, et al. Knowledge of sexual abuse and resistance ability among children with intellectual disability. Child Abuse & Neglect, 2023,136:1-12

11 Estruch G V, Gil L M D, Fernández G O, et al. An affective-sexual education program for people with moderate intellectual disabilities: Analysis of its effectiveness in the Spanish context. Perspectives on Sexual & Reproductive Health, 2025, 57(1):95-103

12 52 Gürol A, Polat S, Oran T. Views of mothers having children with intellectual disability regarding sexual education: A qualitative study. Sexuality and Disability, 2014, 32(2):123-133

13 26 28 Fadime U T. Determination of sexual developmental characteristics of adolescents with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities, 2022, 26(3):672-686

14 王雁,李海燕.韩国智力落后儿童性教育的发展及启示.中国特殊教育,2004,(1):86-91

15 唐诚,文强,夏瑞,等.重庆市智障青少年性教育现状分析及对策探讨.中国性科学,2014,23(8):71-73

16 54 Curtiss S, Stoffers M. Service models for providing sex education to individuals with intellectual disabilities in the United States. Journal of Intellectual Disabilities, 2024, 28(2):434-452

中国知网 https://www.cnki.net

17 Stein S, Kohut T, Dillenburger K. The importance of sexuality education for children with and without intellectual disabilities: What parents think. Sexuality and Disability, 2018, 36(2): 141–148

18 GOV. UK. Relationships and sex education. https://www.gov.uk/government/publications/experiences–of–relationships–and–sex–education–rse, 2026–04–21

19 24 40 Kamaludin N N, Muhamad R, Yudin Z M, et al. "Providing sex education is challenging": Malay mothers' experience in implementing sex education to their children with intellectual disabilities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(12): 1–20

20 van den Toren S J, de Haas S, Dalmijn E, et al. A mixed methods evaluation of Girls' Talk plus: A sexuality education programme for girls with mild intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 2022, 35(4): 1009–1018

21 43 Kamaludin N N, Muhamad R, Yudin Z M, et al. Barriers and concerns in providing sex education among children with intellectual disabilities: Experiences from malay mothers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(3): 1–14

22 Ariyanti T D, Royanto L R M. The effectiveness of social stories and video modeling in improving Self–Care skills infemale adolescents with mild intellectual disabilities during menstrual periods. International Conference on Intervention and Applied Psychology (ICIAP)1st, 2018, (135): 190–199

23 兰继军, 田芳, 王颖. 人际圈理论在智力落后儿童性心理健康教育中的应用. 中国特殊教育, 2006, (6): 26–31

25 Garwood M, McCabe M P. Impact of sex education programs on sexual knowledge and feelings of men with a mild intellectual disability. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 2000, 35(3): 269–283

27 Achey N, Caron S L, Brinck E A. Exploring direct support professionals' perspectives on the sexuality of individuals with mild to moderate intellectual disabilities: A qualitative study. American Journal of Sexuality Education, 2025, (1): 1–32

29 Future of Sex Education. National Teacher Preparation Standards for Sex Education. https://www.future6–04–21ofsexed.org/sex–ed–standards, 2026–04–21

29 Future of Sex Education. National Teacher Preparation Standards for Sex Education. https://www.future6–04–21ofsexed.org/sex–ed–standards, 2026–04–21

30 WHO Regional Office for Europe and BZgA. Standards for sexuality education in Europe. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2010. chrome–extension://lfbmnmiemfdehdapacddddlboccgoegi/index.html? file=https%3A%2F%2Fwhocc.bioeg.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDokumente%2FBIOEG_Standards_English.pdf&size=893041, 2026–04–21

31 中华人民共和国教育部.《培智学校义务教育课程标准(2016年版)》的通知. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3331/201612/t20161213_291722.html, 2026–04–21

33 Andreassen K, Quain J, Castell E. Stop leaving people with disability behind: Reviewing comprehensive sexuality education for people with disability. Health Education Journal, 2024, 83(8): 830–840

34 Grove L, Morrison B D, Kirby R, et al. The birds, bees, and special needs: Making evidence–based sex education accessible for adolescents with intellectual disabilities. Sexuality and Disability, 2018, 36(4): 313–329

35 Viknesh S, Yunus F W, Kadar M, et al. Development of sexuality education teaching guidelines and activity kit for parents of children aged 4–12 years with mild intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 2025, 38(5): 1–9

36 Celik P, Lithari E. Relationships and sex education in special schools: Highlighting the need for safeguarding for children with learning disabilities. Sex Education–Sexuality Society and Learning, 2026, 26(1): 52–63.

37 UNESCO. The journey towards comprehensive sexuality education: global status report. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379607, 2026–04–21

38 Aljudaya A. Teachers' attitudes toward aexual education for Students with intellectual disabilities. Sexuality and Disability, 2025, 44(1): 1–22

39 Stoffelen J M T, Herps M A, Buntinx W H E, et al. Sexuality and individual support plans for people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 2017, 61(12): 1117–1129

41 Guenoun T, Smaniotto B, Clesse C, et al. Representations of sexuality among persons with intellectual disability, as perceived by professionals in specialized institutions:

中国知网 https://www.cnki.net

A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(8): 1–18

42 Paulauskaite L, Rivas C, Paris A, et al. A systematic review of relationships and sex education outcomes for students with intellectual disability reported in the international literature. Journal of Intellectual Disability Research, 2022, 66(7): 577–616

44 Bárcena Gaona S X, Jenkins B C, Macías Dávila E N, et al. Improving self–efficacy and communication about sexuality in families of individuals with intellectual disabilities: Results from an online course. Sexuality and Disability, 2025, 44(1): 1–17

45 Curtiss S L, Stoffers M. Disseminating resources online for teaching sex education to people with developmental disabilities. Sexuality and Disability, 2021, 39(4): 751–760

46 Brown M, Linden M, Marsh L, et al. Learning for life, friendships and relationships from the perspective of children and young people with intellectual disabilities: Findings from a UK wide qualitative study. BMC Public Health, 2024, 24(1): 1–9

47 Fu W Q, Huang L H, Liu R D, et al. Special education teachers' attitudes towards teaching sex education to students with intellectual disabilities in Malaysia. International Journal of Developmental Disabilities, 2024, (4): 1–12

48 Jeyachandran V, Ranjelin S P D, Kumar A. Sexual health and safety of adolescents with intellectual disability: Challenges and concerns among special educators in India. Journal of Intellectual Disabilities, 2024, 28(1): 104–117

49 钱霖亮. "危险"的性意识:对福利院残疾儿童性教育的反思. 浙江工商大学学报, 2017, (6): 106–116

50 53 Isler A, Beytut D, Tas F, et al. A study on sexuality with the parents of adolescents with intellectual disability. Sexuality and Disability, 2009, 27(4): 229–237

51 Sari H, Pirsin T. Attitudes of Turkish parents toward sex education of their intellectual disability children. Makara Journal of Health Research, 2022, 26(1): 36–43

55 于冲. 智力残疾儿童性教育主题活动的行动研究. 硕士论文. 乌鲁木齐:新疆师范大学, 2022

A Systematic Review of Research on Sex Education for Children with Intellectual Disabilities

ZHANG Yang　CHEN Nuo　SHENG Feifei　WANG Zhenzhou　LIANG Jian

(College of Special Education, Leshan Normal University, Leshan, 614000)

Abstract　To explore the challenges and development pathways of sex education for children with intellectual disabilities, this study employs a systematic review methodology. The findings indicate that the essence of sex education for children with intellectual disabilities emphasizes sexual health and the development of health relationships, and both theory and practice focus on appropriate sex education; however, the effectiveness of such education and its underlying patterns remain insufficiently understood. The stakeholders responsible for delivering sex education are becoming more diverse and professional, yet ambiguous policies and regulations make it difficult for them to fulfill their designated roles and responsibilities. The curriculum system focuses on the sex education needs of children with intellectual disabilities; nevertheless, owing to inadequate assessment, sex education curricula struggle to meet the individualized developmental needs of these children. Future development of sex education for children with intellectual disabilities calls for refining top–level design to clarify the roles and responsibilities of sex education stakeholders; leveraging digital and intelligent technologies to innovate sex education services for children with intellectual disabilities; building a multi–stakeholder collaborative support network through interdisciplinary cooperation; and continuously optimizing sex education practice on the basis of scientific assessment.

Key words　children with intellectual disabilities　sex education　sexual health

(责任编校:杨希洁)

中国知网　https://www.cnki.net